

1*. Tunicile globului ocular:

- A. Tunica externă este formată din iris și coroidă.
- B. Coroida este porțiunea posterioară a uveei.
- C. Corneea alcătuiește tunica internă.
- D. Sclera reprezintă porțiunea posterioară a tunicii medii.
- E. Toate variantele sunt greșite.

2*. Blefaritele:

- A. Reprezintă afecțiuni chistice ale pleoapelor, foarte des întâlnite.
- B. Reprezintă o acumulare anormală de colesterol și alți constituenți lipidici în țesutul subcutanat palpebral.
- C. Reprezintă o infecție virală a tegumentului pleoapei, cauzată de pox-virusuri.
- D. Se clasifică în anterioare, posterioare, mixte (antero-posterioare).
- E. Tratamentul de elecție: excizia chirurgicală

3*. Afecțiune congenitală a glandei lacrimale este:

- A. Agenezie canaliculară
- B. Dacriocel congenital
- C. Ectopia glandei lacrimale
- D. Obstrucția de canal lacrimo-nazal
- E. Puncte lacrimale sau canalicul bifid

4*. Semnele și simptomele scleritei sunt următoarele cu excepția :

- A. fotofobie
- B. lacrimare
- C. dureri oculare mari
- D. cefalee
- E. secreție mucopurulentă

5*. Care nu este un factor predispozant în decolarea de retină regmatogenă:

- A. vârsta peste 40 de ani
- B. afakia și pseudofakia
- C. hipermetropia
- D. traumatisme oculare
- E. antecedentele personale și familiale pozitive

6*. Care din următoarele nu este un semn vascular al edemului discului optic:

- A. Hemoragii papilare și retiniene peripapilare
- B. Infarcte ale fibrelor nervoase (exudate moi)
- C. Congestia venoasă a vaselor arcuate și peripapilare
- D. Hiperemia capului nervului optic
- E. Ștergerea marginilor discului optic

7*. Următoarea afirmație referitoare la sindromul de ochi uscat este falsă:

- A. Pacienții acuza senzație de nisip în ochi, arsura, uscăciune
- B. Se întâlnește mai des la femei aflate la vârsta menopauzei

7 E

- C. Cea mai frecventa metoda de diagnosticare este prin testul Schirmer
- D. Cauza poate fi productia redusa de lacrimi sau evaporarea excesiva a filumului lacrimal
- E. Tratamentul consta in administrarea de coliruri cu antibiotice pe termen lung

8 D

8* Corneea:

- A. Formează alături de coroida tunica externă a globului ocular
- B. Este o tunică opacă, bogat vascularizată
- C. Prezintă 6 straturi
- D. Este bogat inervată
- E. Prezintă o față externă, concavă, în raport cu umorul apos

9 E

9*. Termenul care definește paralelismul globilor ocular este:

- A. exotropie
- B. esotropie
- C. heterotropie
- D. heteroforie
- E. ortoforie

10 B

10*. Tratamentul în micozele orbitei este:

- A. antibioterapie generală
- B. antimicotice pe cale generală
- C. antiinflamatoare steroidiene
- D. antiinflamatoare nesteroidiene
- E. analgice

11 ABC

11. Corneea:

- A. Este o tunică transparentă.
- B. Formează porțiunea anterioară a tunicii externe.
- C. Este avasculară.
- D. Nu prezintă inervație.
- E. Este inervată de ramuri ale nervului vag.

12 AB

12. Biometria:

- A. Măsoară lungimea axială a globului ocular.
- B. Este unul dintre parametrii esențiali din calculul preoperator al puterii dioptrice a implantului intraocular.
- C. Determină refracția totală a ochiului.
- D. Reprezintă o variantă automatizată a refractometriei.
- E. Se realizează cu un refractometru manual.

13 ADE

13 Edemul alergic acut al pleoapelor:

- A. Se produce prin agioedem, urticarie sau înțepături de insecte sau arahnide.
- B. Uneori poate fi consecutiv utilizării de medicamente precum Cordarone.
- C. Întotdeauna este afectată doar pleopa inferioară.
- D. Simptomatologie: prurit moderat în aria tegumentară edemațiată, senzație de tensiune.
- E. Tratament: creme sau unguente cu antihistaminice, respectiv cu corticosteroizi.

14. Anizometropia:

- A. Reprezintă un factor de risc pentru ambliopie.
- B. Reprezintă o diferență de refracție între cei doi ochi.
- C. Nu se recomandă lentilele de contact.
- D. Se corectează strict chirurgical.
- E. Se corectează doar cu lentile de contact dure.

15. Corpul vitros:

- A. Umple spațiul dintre porțiunea posterioară a capsulei cristaliniene și retina(camera vitroasă).
- B. Este o substanță apoasă.
- C. Este o substanță opacă.
- D. Periferic vitrosul prezintă o condensare numită hialoida.
- E. Baza vitrosului poate fi decolată doar în traumatisme foarte puternice.

16 Refracția oculară este determinată prin următorii parametri:

- A. Lungimea axială a globului ocular.
- B. Raza de curbură a corneei.
- C. Refracția cristalinului.
- D. Profunzimea camerei anterioare.
- E. Consistența vitrosului.

17 Inflamațiile sclerei:

- A. Se numesc sclerite și prezintă două forme principale
- B. Se numesc sclerite și prezintă trei forme principale
- C. episclerita, care interesează straturile profunde ale sclerei
- D. sclerita propriu-zisă interesând straturile superficiale
- E. sclerita propriu-zisă interesând straturile profunde

18 Conjunctivitele virale:

- A. spre deosebire de cele bacteriene, sunt de regula foliculare (prin implicarea tesutului adenoid al conjunctivei profunde)
- B. Conjunctivita vernală este o conjunctivita virală
- C. Conjunctivitele cu adenovirusuri sunt extrem de contagioase, infecția putându-se răspândi prin secreții lacrimale sau secreții ale tractului respirator superior
- D. Tratament etiologic, se va face cu antivirale (aciclovir, ganciclovir, etc.) administrate topic (în geluri)
- E. Tratament trebuie să dureze 30-40 zile

19. Filmul lacrimal este alcătuit din :

- A. Stratul superficial lipidic - are rolul de oxigenare, hrănire și antibacterian prin intermediul lizozimului.
- B. Stratul intermediar apos - este secretat de glandele Zeiss, Moll și Meibomius
- C. Stratul superficial lipidic - împiedică evaporarea stratului apos, protejează suprafața oculară de diverși agenți mecanici, infecțioși
- D. Stratul intermediar apos - este secretat de glandele Krause și Wolfring

E. Stratul profund mucos – asigură stabilitatea filmului lacrimal.

20 Afecțiuni congenitale ale cailor lacrimale :

20 ABC

- A. Puncte lacrimale sau canaliculi supranumerari
- B. Puncte lacrimale sau canalicul bifid
- C. Imperforarea și atrezia punctelor lacrimale - orificile punctelor lacrimale sunt închise
- D. dacriocistita cronică
- E. dacrioadenita cronică

21 Tratatamentul pterigionului:

21 ACD

- A. de baza este excizia chirurgicală cu sau fără diverse tehnici de plastie conjunctivală asociate
- B. doar tratament topic cu coliruri
- C. pentru diminuarea fenomenelor inflamatorii intralezionale se pot efectua injecții cu corticosteroizi în mijlocul formațiunii
- D. recidivele vor fi tratate predominant tot prin metode chirurgicale
- E. recidivele vor fi tratate predominant tot prin tratament topic cu coliruri

22. Simptomatologia și semnele oculare ale sindromului de ochi uscat sunt:

22 ACD

- A. secreție lacrimală vascoasă
- B. secreție lacrimală mucopurulentă
- C. senzația de uscăciune oculară, de nisip în ochi, de corp străin, înțepături, iritație și durere ocular
- D. hiperemie conjunctivală
- E. scăderea acuității vizuale

23 Subpresia producerii de umor apos poate fi indusă de medicamente precum:

23 BCD

- A. Parasimpatomimetice
- B. Inhibitorii de anhidrază carbonică
- C. Betablocanții selectivi sau neselectivi
- D. Alfaagoniștii adrenergici
- E. Esteri de prostaglandine

24 Fac parte din glaucomul cu unghi deschis:

24 ABCD

- A. Hipertensiunea intraoculară
- B. Glaucomul juvenil
- C. Glaucomul cu presiune normală
- D. Glaucomul secundar cu unghi deschis
- E. Atacul de glaucom

25 Decolarea de retină regmatogenă:

25 CD

- A. apare secundar acumulării de lichid subretinian, provenit din vasele sangvine ale retinei neurosenzoriale sau coroidă
- B. nu se caracterizează prin prezența unei rupturi retiniene
- C. se caracterizează prin prezența unei rupturi retiniene
- D. ruptura este menținută deschisă de către tracțiunile vitreoretiniene și permite vitrosului lichefiat să se

acumuleze sub retina neurosenzorială

E. retina neurosenzorială este tractionată și separată de epiteliul pigmentar retinian de către membrane vitreoretiniene fibroase sau fibrovasculare, care se dezvoltă în cavitatea vitreană

26 Retinopatia hipertensivă semne :

A. vasodilatația arteriolară retiniană focală sau generalizată

B. exudate dure maculare cu aspect de stea maculară (hipertensiunea arterială malignă)

C. extravazarea vasculară cu prezența hemoragiilor retiniene

D. modificarea reflexului arterial parietal

E. modificări la nivelul încrucișării arterio-venoase

27 Neuropatia optică ischemică anterioară nonarteritică:

A. este cea mai frecventă neuropatie optică acută la pacienții cu vârsta peste 70 de ani

B. este asociată cu arterita temporală

C. discul optic are o excavație mică

D. AFG : Întârzierea umplerii la nivelul discului optic

E. se tratează cu corticosteroizi

28 Compresia la nivelul nervului optic determină:

A. Durere oculară

B. Defect pupilar aferent relativ

C. Discromatopsie

D. Limitarea mișcărilor oculare

E. Deteriorarea progresivă a câmpului vizual

29. afecțiunile degenerative ale vitrosului:

A. Sunt foarte rare

B. Sunt frecvente

C. Corpii flotanti in vitros apar la varstnici

D. Sinchisisul scintillans este o degenerescenta senila cu impregnatie lipida

E. Sinchisisul scintillans duce la scaderea brusca si accentuata a acuitatii vederii

30 printre afecțiunile congenitale ale vitrosului se numara

A. Vitrita congenitala

B. Hemoragia vitreana

C. Persistenta si hiperplazia vitrosului primitiv

D. Persistenta arteri hialoide

E. Pseudogliomul ereditar

31 Urmatoarele complicatii pot aparea imediat dupa operatia de cataracta:

A. Ruptura capsulei posterioare

B. Hemoragia expulziva

C. Edem cornean mecanic

D. Endoftalmita

E. Hifema

32 Urmatoarele afirmatii referitoare la hemoragia vitreana postcontuziva in urma unui soc violent sunt false:

32 AD

- A. Hemoragia determina o scadere lenta a acuitatii vizuale pe durata catorva zile
- B. Hemoragia determina o scadere brusca a acuitatii vizuale pe durata catorva minute
- C. Fundul de ochi nu se mai lumineaza din cauza vitrosului opac
- D. Nu necesita tratament
- E. Examenul biomicroscopic pune in evidenta prezenta de snage in trama vitreana

33. Arsurile corneene termice pot fi cauzate de:

33 ABD

- A. Radiatii UV
- B. Vaporii
- C. Acizi
- D. Metale incandescente
- E. Baze

34. urmatoarele afirmatii referitoare la keratite sunt adevarate:

34 BC

- A. Keratitele sunt afectiuni congenitale ale corneei
- B. Keratitele sunt afectiuni inflamatorii ale corneei
- C. Sunt insotite de dureri oculare si perioculare
- D. Nu apar blefarospasmul si hiperlacrimarea
- E. Tratamentul este strict chirurgical

35. din punct de vedere subiectiv orice cataracta se manifesta prin

35 ACE

- A. Scaderea acuitatii vizuale
- B. Epifora
- C. Diplopie monoculara
- D. Diplopie binoculara
- E. Scaderea sensibilitatii la contrast

36 Mușchii extrinseci ai globului ocular:

36 BDE

- A. Sunt mușchi netezi.
- B. Realizează mișcările coordonate ale globului ocular.
- C. Originea tuturor mușchilor extrinseci se află la nivelul inelului tendinos al lui Zinn.
- D. Mușchiul drept extern realizează abducția globului ocular.
- E. Mușchiul drept intern realizează adducția globului ocular.

37. Tumorile conjunctive ale orbitei sunt :

37 CDE

- A. hemangiomul cavernos
- B. hemangiomul capilar
- C. lipomul orbitei
- D. fibromul
- E. fibrosarcomul

38 Urmatoarele afirmatii sunt adevarate

38 BCD

- A. Plăgile perforante mici nu se inchid spontan

- B. Plăgile sclerei se produc în aceleași condiții ca și ale corneei
- C. Plăgile perforante mici ce se închid spontan și care nu sunt însoțite de hernierea membranelor nu necesită tratament chirurgical
- D. Plăgile mari, dehiscente, trebuie suturate după rezecția membranelor prolapse
- E. Plăgile mari, dehiscente se închid spontan

39 .Care sunt cauzele de exoftalmie unilaterală ?

- A. celulita orbitară
- B. celulita preseptală
- C. dacriocistită
- D. dacrioadenită
- E. tumori orbitare

39 ADE

40 .Tratamentul strabismelor poate fi :

- A. tratament optic – pentru obținerea unei AV optime pentru dezvoltarea vederii binoculare
- B. tratament ortoptic – pentru dezvoltarea fuziunii și a vederii stereoscopice
- C. tratament chirurgical - indicat în cazurile cu deviații strabice sub 10 °
- D. tratament pleoptic - are rolul de a îmbunătăți AV a ochiului ambliop
- E. tratament medicamentos -miotice și cicloplegice

40 ABDE

41 Urmatoarele afirmatii sunt adevarate

- A. Corpuri străini intraorbitari alcătuiți din plumb, sticlă, mase plastice sunt perfect tolerați
- B. Corpuri străini intraorbitari alcătuiți din plumb, sticlă, mase plastice nu sunt tolerați
- C. Corpuri străini compusi din lemn și resturi vegetale produc leziuni inflamatorii
- D. Corpuri străini compusi din lemn și resturi vegetale nu produc leziuni inflamatorii
- E. Unii corpi străini intraorbitari determină fistule palpebrale, prin care se scurge puroi

41 ACE

42 Edemul Berlin

- A. Forma particulară de edem specifică polului posterior în cazul traumatismelor contuzive ale globului ocular.
- B. Este caracterizat de edemul pleoapelor
- C. Reprezintă edemul endoteliului cornean
- D. Apare la examenul oftalmoscopic de culoare alb-cenusie
- E. Ocupă întreg polul posterior

42 ADE

43 Modificările cristalinului în urma unei contuzii oculare sunt

- A. Cataractă senilă
- B. Luxație
- C. Subluxație
- D. Cataractă traumatică
- E. Cataractă congenitală

43 BCD

44 .Exoftalmie este clasificată astfel :

- A. exoftalmie medie <12 mm
- B. exoftalmie medie 17-20 mm
- C. exoftalmie medie 12-16 mm

44 BE

- D.exoftalmie mare 17-20 mm
- E.exoftalmie mare > 20 mm

45. Complicațiile unei plăgi oculare netratate sunt reprezentate de

- A. Degenerescenta maculară legată de vârstă
- B. Endoftalmită
- C. Uveită exudativă
- D. Glaucom primar cu unghi deschis
- E. Neuropatie optică ischemică anterioară

46 Care din următoarele nu reprezintă Indicație absolută pentru enuclearea globului ocular

- A. Plăgi de mici dimensiuni
- B. Plăgile însoțite de distrugerii intraoculare grave
- C. Plăgile mari zdrobite
- D. Plăgile a căror coaptare este imposibilă
- E. Plăgi întepate

47. Care sunt principalele cauze de exoftalmie bilaterală ?

- A. celulita orbitară
- B. craniostenoză
- C. tromboflebită de sinus cavernos
- D. hidrocefalia
- E. boala Basedow

48. În strabismul paralizic, semnele obiective sunt :

- A. deviația globului ocular în aceeași direcție cu mușchiul paralizat
- B. deviația globului ocular în direcția opusă mușchiului paralizat
- C. torticolis
- D. limitarea mișcării globului ocular în direcția de acțiune a mușchiului paralizat
- E. limitarea mișcării globului ocular în direcția de acțiune opusă mușchiului paralizat

49 În cazul unui traumatism contuziv retina poate prezenta următoarele modificări patologice:

- A. Degenerescenta maculară
- B. Hemoragii
- C. Edem
- D. Rupturi
- E. Dezlipiri de retina

50 Modificările oculare întâlnite în cazul plăgilor perforante sunt reprezentate de

- A. Dispariția camerei anterioare, datorită scurgerii umorii apoase
- B. Hipertonie oculară
- C. Hipotonie oculară
- D. Inclavarea sau hernierea irisului în plagă
- E. Hemoragii vitreene sau chiar hemoftalmus, în cazul lezării corpului ciliar sau a coroidelor